

· 文献研究 ·

据天回医简校读《内经》五则

顾 漫, 周 琦

(中国中医科学院中国医史文献研究所, 北京 100700)

摘 要: 天回医简有不少内容与传世医书可以比较互证, 使得我们能以之为依据, 更加具体地讨论相关传世医书的来源与形成过程, 并纠正后者流传中形成的一些讹误, 释疑解难。借助与天回医简的互校, 对《黄帝内经》“疹筋”“不表不里”“快然”“去爪”“马刀”五则存在理解障碍或争议的文句, 重加校勘训诂, 提出新的意见, 以期引起学界对出土古文献材料在《内经》校读中价值的重视, 共同推进中医“古典学的重建”。

关键词: 天回医简;《黄帝内经》; 出土文献; 校读

DOI: 10.16307/j.1673-6281.2022.02.011

中图分类号: R221 文献标志码: A 文章编号: 1673-6281(2022)02-0181-06

Collation and Explanation of Five Terms in *Huáng Dì Nèi Jīng*: Based on Tianhui Medical Bamboo Slips

GU Man, ZHOU Qi

China Institute for the History of Medicine & Medical Literature, China Academy of Chinese Medical Sciences,
Beijing 10070, China

【Abstract】 Many contents recorded on Tianhui medical bamboo slips and handed-down medical books can be compared and verified with each other. Therefore, Tianhui medical bamboo slips can be used to explore the source, writing and compilation of related medical classics, correct some mistakes made in their circulation and solve problems. With the help of Tianhui medical bamboo slips, this paper collates and reinterprets five complicated or controversial terms in the *Huáng Dì Nèi Jīng* (《黄帝内经》, *Huangdi's Internal Classic*) including “zhěn jīn” (疹筋), “bù biǎo bù lǐ” (不表不里), “kuài rán” (快然), “qù zhuǎ” (去爪), and “mǎ dāo” (马刀). This paper attempts to arouse the academic community's attention to the value of unearthed literature in the collation of *Huangdi's Internal Classic* and promote the “reconstruction of classics” of traditional Chinese medicine.

【Keywords】 Tianhui Medical Bamboo Slip; *Huáng Dì Nèi Jīng* (《黄帝内经》, *Huangdi's Internal Classic*); Unearthed Literature; Collation

〔基金项目〕 国家社会科学基金重点项目 (18AZS004)

〔第一作者〕 顾漫 (ORCID: 0000-0002-1638-3099), 研究员, E-mail: guman126.com

〔通信作者〕 周琦 (ORCID: 0000-0002-3849-4718), 副研究员, E-mail: 6269888@qq.com

既往出土的秦汉简帛医书中有一些和传世医书密切相关的内容，但对探索传世医书的来源和形成过程有价值的例子不是很多。天回医简则有不少文句可与传世医书比较互证，而且天回医简既有“敝昔（扁鹊）”这种非常明确的标志，又有可与《史记·仓公传》对照的较为清晰的传承脉络。这使得我们能以之为坐标，比过去更加具体地讨论传世医书的来源和形成过程。我们在整理中发现，与天回医简互校，可以对《黄帝内经》相关文句的校勘训诂提出一些新的意见。兹就管见所及，略举五例以阐发之，与同道商榷。

一、疹筋

《素问·奇病论篇》：

帝曰：人有尺脉数甚，筋急而见，此为何病？岐伯曰：此所谓疹筋，是人腹必急，白色黑色见，则病甚。^{[1]94}

疹筋：《内经》教学参考书注释为“疹，病也。疹筋，筋之病变”，所据为张介宾《类经》注：“疹筋者，病在筋也。”^{[2]439}《释名·释疾病》：“疹，诊也，有结聚可得诊见也。”^[3]据《释名》所训，似可释“疹筋”为“筋有结聚”，较仅释为“筋病”更合于经义。而《释名》此处所释“结聚”，当与《史记·扁鹊仓公列传》“以此视病，尽见五藏癥结”之“癥结”义同，即由具体有形的病逐渐抽象和泛化为“疾病”概念本身的喻指。这也是后世注家将“疹”径训为“病也”的缘由。

疹筋，《甲乙经》卷四“病形脉疹第二上”作“狐筋”。^{[4]152}“狐”与“疹”古字形易发生讹混，但此异文并未得到《内经》注家的重视。天回医简《脉书·下经》中出现了“狐”这一病名，且作为一疾病大类记述，相关医简有 12 支，^{[5]183,186}足可见其重要性。并有“直狐，坚，直少腹”^{[5]187}（简 384）以及“狐之阳瘕……腹、少腹尽痛，偃（胀）而阴筋痛”（简 616）的症状描述，指出狐病的症状以少腹部、腹部硬满疼痛为主，与《奇病论》“疹筋”腹部紧张、拘急的症状表现可以对应。

“狐”作为病名，见于《金匱要略·跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治第十九》：“阴狐疝气者，偏有小大，时时上下，蜘蛛散主之。”^[6]《千金要方》卷三十针灸下“孔穴主对法”商丘穴主治有“狐疝走上下引小腹痛，不可以俯仰”^[7]。《儒门事亲》卷二“疝本肝经宜通勿塞状十九”立寒疝、水疝、筋疝、血疝、气疝、狐疝、癰疝“七疝”之名，并详述其证候：“狐疝，其状如瓦，卧则入小腹，行立则出小腹入囊中。狐则昼出穴而溺，夜则入穴而不溺。此疝出入，上下往来，正与狐相类也。”^[8]《明医指掌》卷六“疝证八”歌云：“寒水癰血气狐筋，先哲空留七疝名。盖是肝经原有热，外边却被湿寒侵。”^[9]余云岫业已指出“疝病之名，古今异趣”^[10]，从天回医简《脉书·下经》对诸病名候的记述亦可证此，其中的“疝病”多指心腹痛证；而“狐病”则症见体腔内有物突出，时隐时现，伴少腹、阴筋疼痛，小便不利等，类似今之腹股沟疝。我们知道，当腹股沟疝发生嵌顿时，会引发剧烈的疼痛，局部可触及疝内容物形成的包块，触感紧张发硬，与“筋急而见”的形容相当切合。由此可证，《甲乙经》作“狐筋”于传本有据，看起来是对“狐疝”一类病证的描述；而《素问》《太素》中的“疹筋”，在他书中几无对证，很可能存在传写之误。

二、不表不里，其形不久

《灵枢·寿夭刚柔篇》：

病有形而不痛者，阳之类也；无形而痛者，阴之类也。无形而痛者，其阳完而阴伤之也，急治其阴，无攻其阳；有形而不痛者，其阴完而阳伤之也，急治其阳，无攻其阴。阴阳俱动，

乍有形，乍无形，加以烦心，命曰阴胜其阳，此谓不表不里，其形不久。^{[11]20}

此谓不表不里，其形不久。马蒔注云：“病有阴阳俱病，形似有无而心为之烦，此乃阴经阳经各受其伤，而阴为尤甚，欲治其表，阴亦为病，欲治其里，阳亦为病，治之固难，形当不久矣。”^[12]《素问·奇病论篇》：“今外得五有余，内得二不足，此其身不表不里，亦正死明矣。”^{[1]95}亦言“不表不里”为死证，可与《寿夭刚柔篇》互证。

天回医简《逆顺五色脉藏验精神》：“病不表，不【可以鑱】石。病不裹（里），不可以每（毒）药。不表不【里者】，（简 707）^[13]为视“不表不里”为死证的认识提供了早期证据。《素问·移精变气论》在论及祝由时云：“今世治病，毒药治其内，针石治其外，或愈或不愈，何也……故毒药不能治其内，针石不能治其外，故可移精祝由而已。”^{[1]31-32}《素问·汤液醪醴论篇》：“当今之世，必齐毒药攻其中，鑱石针艾治其外也。”^{[1]33}皆可见“鑱石”（或针石）与“毒药”相对为文，与医简之文同义，为当时医家治病常法。又《素问·奇病论篇》：“所谓无损不足者，身羸瘦，无用鑱石也。”^{[1]94}与《史记·仓公所述“尸夺者，形弊；形弊者，不当关灸鑱石及饮毒药也”^{[14]2802}相合。又《史记·仓公传》仓公曰：“论曰：阳疾处内，阴形应外者，不加悍药及鑱石。”^{[14]2811}“悍药”与“毒药”义同；而据“论曰”文例，此当为仓公称引扁鹊之医论。《鹖冠子·世贤》：“若扁鹊者，鑱血脉，投毒药，副肌肤间，而名出闻于诸侯。”^[15]可知在治疗方法上，扁鹊善用鑱石、毒药，代表了当时的医学主流，时人皆耳熟能详。在治疗原则上，扁鹊则以表里分阴阳，用以指导“鑱石”和“毒药”两大类治疗方法的临证施用：病在表属阳，以鑱石、针艾攻之；病在里属阴，以毒药、汤液达之；若其病非表非里，则攻之不可，达之不及，治之无方，故为死证。《灵枢·寿夭刚柔篇》《素问·奇病论篇》等篇中有关“不表不里”的论述在出土医经文献中得以印证，显示了今本《黄帝内经》对扁鹊医经理念的传承。

三、快然



图 1 天回医简 421

“後與氣則律然”

《灵枢·经脉篇》：

脾足太阴之脉……是动则病舌本强，食则呕，胃脘痛，腹胀善噫，得后与气则快然如衰，身体皆重。^{[11]31}

“得后与气则快然如衰”：《太素》杨上善注：“谷入胃已，其气上为营卫及膻中气，后有下行与糟粕俱下者，名曰余气。余气不与糟粕俱下，壅而为胀，今得之泄之，故快然腹减也。”^{[16]190}“快然如衰”：马王堆帛书《阴阳十一脉灸经甲本》21 作“快然衰”^{[17]200}，乙本 20 作“逢然衰”^[18]，张家山竹简《脉书》简三四“快然衰”三字原残，据帛甲本补^{[19]121}。《长沙马王堆汉墓简帛集成》注释说：“魏启鹏、胡翔骅（1992：29）：快，通‘佚’‘逸’，安逸、舒服。今按：‘逢’与‘快’写法迥异，‘快’字，从其构形看，应该是一个从‘心’‘失’声之字，战国楚文字中通常用为‘失’的字写作‘避’，或隶定为‘逯’，……而‘逸’与‘失’或从‘失’声之字往往通假……‘逢’字在秦汉文字中或写作‘逢’，从‘羊’讹变作‘丰’形。可知帛书乙本的‘逢’应该就是‘避（逯）’字之形讹。而《灵枢·经脉》等医籍中与甲本‘快’相当的‘快’则显然是‘快’字的形讹。”^{[17]200}已有学者指出，马王堆简帛保留有不少楚文字遗迹，主要就是受到楚系抄本的影响^[20]。马王堆帛乙本的抄写者大概因对“逯”字的楚文形态不甚了解，而将其讹写作近似“逢”形之字。天回医简《脉书·下经》“快然”作“律然”（简 421，图 1），看来也是从“逯（逯）”字形讹而来，与帛乙本作“逢”字的情况近似。由此字形的差异，我们可以推测这几种经

脉文献来自不同的传承，其所据底本用不同文字书写：帛乙本与天回简可能都是据战国文字书写的底本转抄的，而《灵枢·经脉篇》所据的底本则是近于帛甲本的已转写为秦汉文字的抄本（其字形衍变关系参见图 2）。

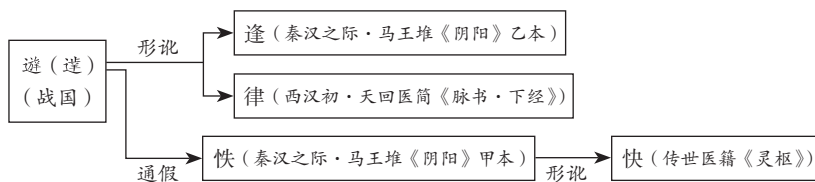


图 2 字形衍变关系表

四、去爪

《灵枢·刺节真邪篇》：

黄帝曰：刺节言去爪，夫子乃言刺关节肢络，愿卒闻之。岐伯曰：腰脊者，身之大关节也；肢（股）胫者，人之管（所）以趋翔也；茎垂者，身中之机，阴精之候，津液之道也。故饮食不节，喜怒不时，津液内溢，乃下留于睾，血（水）道不通，日大不休，俯仰不便，趋翔不能。此病荣（荣）然有水，不上不下，铍石所取，形不可匿，常不得蔽，故命曰去爪。帝曰：善。^{[21]487}

爪：《甲乙经》卷九“足厥阴脉动喜怒不时发癰疽遗溺癰第十一”作“衣”。^{[4]309}《太素·五节刺》杨上善注：“或‘水’字错为‘爪’字耳。”^{[16]705}郭霭春先生赞同杨注^{[21]484}。黄龙祥先生则认为“去爪”当作“去瓜”。^[22]按“爪”与“衣”，皆为“水”字形近之讹，杨说当从。详后文义，“去爪”所刺之病，为水留滞于腰脊、股胫、茎垂之处，“水道不通，日大不休”则身形肿大，平常所穿的衣服已不合身，是为“裳不得蔽”（《灵枢》原文“常”字误，当从《甲乙经》作“裳”字）。因而，这种治法应称作“去水”。这一称谓在汉时并不鲜见，如《淮南子·缪称训》：“大戟去水，亭历愈张，用之不节，乃反为病。”^[23]而峻下逐水的另一代表药芫花，在《本经》中的异名即作“去水”。^[24]天回医简《刺数》：“刺（刺）水，葢（针）大如履葢（针），□三寸。”（简 653）^[25]其中“水”字的字形作，稍有漫漶则极易与“衣”“爪”字的古隶形态混淆；其所用之针具亦较大，相当于《灵枢》中的“大针”。《灵枢·九针十二原篇》：“大针者，尖如挺，其锋微员，以泻机关之水也。”^{[11]6}恰恰是用于“去水”的；而《刺节真邪》“去水”所针对的，包括“腰脊”“股胫”等关节肢络，及被称为“身中之机”的“茎垂”，正是大针所主治的“机关之水”。故《刺数》中作为古刺法之一的“刺水”，应为“五节刺”中“去水”之滥觞，亦可证《刺节真邪》“去爪”当是“去水”传写之误。

五、马刀

《灵枢·痈疽篇》：

发于腋下，赤坚者，名曰米疽。治之以砭石，欲细而长，疏砭之，涂以豕膏，六日已，勿裹之。其痈坚而不溃者，为马刀挟癭，急治之。^{[11]135}

马刀：《内经》教学参考书将其与“侠癭”合解，注释为“病名。属瘰癧之类。常成串而出，质坚硬，其形长者称为马刀，或生于耳下、颈项，至缺盆沿至腋下，或生肩上而下沿。”^{[2]462}其注力求调和诸说，却导致释义不明。按《灵枢》原文已将其归于“发于腋下”之类，其言“其痈坚而不溃者”，显然是与“赤坚者”对举，故“马刀”就部位而言，当属腋下痈疽之名。《诸病源候论·疽候》亦可佐证：“发于

掖下，赤坚者，名曰米疽也；坚而不溃者，为马刀也。”^[26]

《灵枢·经脉篇》：“胆足少阳之脉……是主骨所生病者……腋肿，马刀侠癰。”“马刀”归于足少阳脉的“所生病”，且查检《甲乙经》所录治疗“马刀”的穴位，多取足临泣、阳辅、渊液、章门等足少阳脉之穴，可见其发病部位当处在足少阳脉的循行路径上。又《甲乙经》卷八“五藏传病发寒热第一下”引《明堂》条文三见“腋肿”与“马刀癰”并举^{[4]271-272}，也提示其部位近于腋下；与“马刀”并见者，还有“马疡”这一病名，《甲乙经》卷三“腋肋下凡八穴第十八”引《明堂》：“渊液，在腋下三寸宛宛中，举臂取之，刺入三分，不可灸，灸之不幸，生肿蚀马刀伤，内溃者死，寒热生马疡可治。”注文引《素问·气穴论》注指出渊液穴乃“足少阳脉气所发”^{[4]106}，提示马刀、马疡的发病部位应在渊液穴周边的腋下部；而渊液穴同时亦是治疗马刀的主穴，如《甲乙经》卷九第四有“胸满马刀，臂不得举，渊液主之”^{[4]295}，卷十一第九下“马刀肿癰，渊液、章门、支沟主之”^{[4]353}。

在出土医书中，出现了“马”这一病名，《足臂十一脉灸经》7-8：“足少阳脉……其病……胁痛，□痛，产马。”^{[17]189}《脉书》简四：“在夜（腋）下，为马。”^{[19]115}在天回医简中则写作“𦛗”或“𦛗”，如天回医简 303：“少阳产癰产𦛗，肋外腫（肿）。”简 594：“（足少阳脉）腋𦛗痛。”（图 3）从其发病部位在腋下、及属于足少阳脉所产病等描述，我们不难将其与《灵枢》《甲乙经》所见之“马刀”联系起来；“马”与“马刀”所指既可相同，则显然不是对痈疽形状的描述。从天回简的文字看，“𦛗”从肉（月）部，当指某一人体部位；“𦛗”从病部，则是与此部位相关的病名。《说文·病部》：“𦛗，目病。一曰恶气箸身也。一曰蚀创。”^[27]其“目病”之义，显然与此不合；《五十二病方》目录有“治𦛗”，其方云：“𦛗者，痈痛而溃。”^{[17]297}亦指痈疽类的疾病，与《灵枢》同，并与《说文》所云“蚀创”义近。天回髹漆经脉人身上的铭文中亦出现“腋渊”一名（笔者按：原字形作“夾淵”），标注于腋下部位，与《灵枢》《明堂》所言之“渊液”相当^[28]。

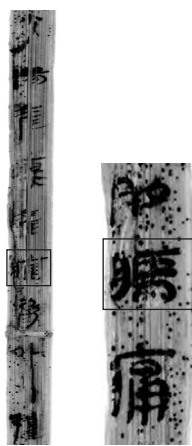


图 3 天回医简简 303、594

通过以上文献梳理，我们认为《灵枢·痈疽篇》和《经脉篇》中“马刀”这一病名，很可能来源于出土医书中的“马”病；反过来，传世医籍中的相关记载也有助于我们释读出土医书中出现的“𦛗”“𦛗”等字。其病特征是发病部位在腋下，为足少阳脉循行所过，属于痈疽一类的病证，治疗常取用邻近的渊液穴。故其与发于颈项的瘰癧本非一病，不应混淆。

裘锡圭先生指出：“出土文献在研究古书的真伪与时代、古书的体例与源流、古书的校勘与解读等古典学问题上，可以发挥极为突出的重要作用。”^{[29]19}并对“中国古典学的重建”做出展望：“大量出土文献的发现、整理与研究，为中国古典学的重建提供了前所未遇的有利条件。与古典学研究密切相关的出土文献未来还会继续问世，已发表的出土文献有些仍需重新整理、继续研究。”^{[29]24}天回医简作为新出土的

早期医学文献,在中医经典的校读方面可以发挥传世文献难以替代的重要作用,这已经引起学界的关注和讨论^[30]。而对于已发表的出土医书,其在《内经》校读中的价值仍有待继续发掘。近年来,一些从事《内经》教学和研究的学者开始重视出土文献的价值^[31]。希望这种“二重证据法”的运用将来能够蔚然成风,推动中医“古典学的重建”取得进展,不落后尘。

参考文献

- [1] 黄帝内经素问[M].明顾从德刊本影印本.北京:人民卫生出版社,1956.
- [2] 程士德.内经:第2版[M].北京:人民卫生出版社,2006.
- [3] 许慎,等.汉小学四种:下册[M].成都:巴蜀书社,2001:1553.
- [4] 皇甫谧.针灸甲乙经[M].周琦,校注.北京:中国医药科技出版社,2019(第2版).
- [5] 梁繁荣,王毅.揭秘敝昔遗书与漆人——老官山汉墓医学文物文献初识[M].成都:四川科学技术出版社,2016.
- [6] 何任.金匱要略校注[M].北京:人民卫生出版社,2013:166.
- [7] 李景荣,苏礼,任娟莉,等.备急千金要方校释[M].北京:人民卫生出版社,2014:1069.
- [8] 张从正.子和医集[M].邓铁涛,等编校.北京:人民卫生出版社,1994:87.
- [9] 皇甫中.明医指掌[M].北京:人民卫生出版社,1982:170.
- [10] 余云岫.古代疾病名候疏义[M].北京:学苑出版社,2012:239.
- [11] 灵枢经[M].明赵府居敬堂刊本影印本.北京:人民卫生出版社,1956.
- [12] 马蒨.黄帝内经灵枢注证发微[M].田代华,主校.北京:人民卫生出版社,1994:45.
- [13] 柳长华,顾漫,周琦,等.四川成都天回汉墓医简的命名与学术源流考[J].文物,2017(12):58-69.
- [14] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.
- [15] 黄怀信.鹖冠子校注[M].北京:中华书局,2014:323.
- [16] 李克光,郑孝昌.黄帝内经太素校注[M].北京:人民卫生出版社,2005.
- [17] 裘锡圭.长沙马王堆汉墓简帛集成[M](伍).北京:中华书局,2014.
- [18] 裘锡圭.长沙马王堆汉墓简帛集成[M](陆).北京:中华书局,2014:11.
- [19] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组.张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕[M]释文修订本.北京:文物出版社,2006.
- [20] 周波.战国时代各系文字间的用字差异现象研究[M].北京:线装书局,2012:283-324.
- [21] 郭霭春.黄帝内经灵枢校注语译[M].天津:天津科学技术出版社,1999:484.
- [22] 黄龙祥.中国古典针灸学大纲[M].北京:人民卫生出版社,2019:259-261.
- [23] 何宁.淮南子集释[M].北京:中华书局,1998:756-757.
- [24] 森立之.神农本草经[M].北京:北京科学技术出版社,2016:66.
- [25] 顾漫,周琦,柳长华.天回汉墓医简中的刺法[J].中国针灸,2018,38(10):1073-1079.
- [26] 丁光迪.诸病源候论校注[M].北京:人民卫生出版社,2013:605.
- [27] 段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:349.
- [28] 黄龙祥.老官山出土西汉针灸木人考[J].中华医史杂志,2017,47(3):131-144.
- [29] 裘锡圭.老子今研[M].上海:中西书局,2021.
- [30] 钱超尘.《成都天回汉墓竹简》可正《内经》《伤寒》文字之失[J].中医文献杂志,2020,38(1):1-2.
- [31] 朱鹏举.浅谈出土古文献材料在研读《黄帝内经》中的重要价值[J].中医教育,2018,37(2):78-80.

(本文编辑 黄晓华)